

Diretoria de Assistência à Saúde
Diretoria de Políticas de Saúde
Diretoria Técnica

Nota Técnica Conjunta nº 01/2025 - SES.DAS/DPS/DTE

Assunto: Atualização da recomendação do tratamento de Sífilis em Gestantes

A Secretaria da Saúde, por meio da Diretoria de Assistência à Saúde, Diretoria de Políticas de Saúde e Diretoria Técnica, atualiza a recomendação do tratamento de sífilis em Gestantes no Município de Joinville, de acordo com o Ministério da Saúde.

ANÁLISE

A benzilpenicilina benzatina é o medicamento de escolha para o tratamento da Sífilis, sendo a única droga com eficácia comprovada durante a gestação. Não há evidências de resistência do *Treponema pallidum* à penicilina no Brasil e no mundo.

Qualquer outro tratamento realizado durante a gestação, para fins de definição de caso e abordagem terapêutica de Sífilis Congênita, será considerado tratamento inadequado da mãe, resultando na notificação do recém-nascido como Sífilis Congênita e requerendo avaliação clínica, laboratorial e tratamento pós parto.

O tratamento da Sífilis em Gestante deve ser iniciado o mais precocemente possível. Considera-se tratamento adequado para Sífilis durante a gestação aquele que é completo para o respectivo estágio clínico da Sífilis, feito com benzilpenicilina benzatina e iniciado até 30 dias antes do parto. Gestantes que não atendam a esses critérios serão consideradas inadequadamente tratadas.

Para Gestantes, o intervalo ideal entre as doses é de 7 (sete) dias. Caso a Gestante não retorne à Unidade de Saúde para receber as doses subsequentes, é necessário realizar imediatamente a busca ativa. Se houver atraso entre as doses superior a 9 (nove) dias, é necessário repetir o esquema terapêutico completo.

Qualquer intervalo **superior a 9 (nove) dias ou inferior a 7 (sete) dias** entre as doses, será considerado tratamento inadequado.



Assim, visando alinhar a Linha de Cuidado para Atenção Integral à Pessoa com Sífilis do Município de acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Prevenção da Transmissão Vertical de HIV, Sífilis e Hepatites Virais (PCDT-TV) do Ministério da Saúde (MS), verificou-se a necessidade de atualizar a recomendação do tratamento, que deve ocorrer conforme a classificação clínica da infecção.

O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Prevenção da Transmissão Vertical do HIV, Sífilis e Hepatites Virais (BRASIL, 2022) recomenda que Gestante com diagnóstico de **Sífilis recente (primária, secundária, latente recente)**, ou seja, até um ano de infecção, **deve ser tratada com 2 (duas) ampolas de penicilina**. E no caso da Gestante com diagnóstico de **Sífilis tardia (latente tardia, latente com duração ignorada e terciária)**, ou seja, com mais de 1 (um) ano de infecção, **deve ser tratada com 6 (seis) ampolas de penicilina**.

O quadro (Quadro Único) a seguir apresenta os esquemas terapêuticos recomendados para Sífilis na gestação, de acordo com a classificação clínica da infecção, atualizando a recomendação constante na Linha de Cuidado para Atenção Integral à Pessoa com Sífilis, no Quadro 4 do Item 4.2 - Tratamento da Sífilis em Adultos e Gestantes (Processo SEI Nº 23.0.299742-0).

Quadro Único. Tratamento e monitoramento de Sífilis em Gestante

Estadiamento	Esquema Terapêutico	Monitoramento
Sífilis recente • Primária; • Secundária; e • Latente recente (até um ano de evolução).	Benzilpenicilina benzatina 2,4 milhões de UI, IM dose única, (1,2 milhão de UI em cada glúteo).	VDRL mensal
Sífilis tardia • Sífilis latente tardia (com mais de um ano de evolução); ou • Latente com duração ignorada; e • Sífilis terciária.	Benzilpenicilina benzatina 2,4 milhões de UI, IM, 1 x na semana, (1,2 milhão de UI em cada glúteo) por 3 semanas. Dose total 7,2 milhões de UI.	VDRL mensal
Neurossífilis	Benzilpenicilina potássica/cristalina 18/24 milhões UI ao dia, EV, administradas em dose de 3-4 milhões de UI, a cada 4 horas ou por infusão contínua, por 14 dias.	Exame de LCR de 6/6 meses até a normalização.

Fonte: BRASIL, 2023

No apêndice (Apêndice Único) abaixo, são sugeridas boas práticas para a garantia do intervalo adequado entre as doses de benzilpenicilina benzatina no tratamento da Sífilis em Gestantes.

Para demais informações sobre o cuidado das pessoas com diagnóstico de Sífilis, consultar a Linha de Cuidado para Atenção Integral à Pessoa com Sífilis (Processo SEI Nº 23.0.299742-0).



REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Departamento de HIV/AIDS, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis. **Nota Técnica nº 14/2023 - DATHI/SVSA/MS**. Dispõe sobre atualização da recomendação do intervalo entre doses de benzilpenicilina benzatina no tratamento de sífilis em gestantes. Brasília - DF: 2023. Disponível em: https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/notas-tecnicas/2023/sei_ms_-_0034352_557_-_nota_tecnica_penicilina.pdf/view. Acesso em 05/03/2025;

SANTA CATARINA. Prefeitura de Joinville. Secretaria da Saúde. Diretoria de Políticas de Saúde. Gerência de Enfermagem e Núcleo de Gestão Assistencial. **Linha de Cuidado para Atenção Integral à Pessoa com Sífilis**. Joinville - SC: 2023;

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. **Atualização do Caderno de Atenção Básica 18: HIV/Aids, Hepatites Virais, Sífilis e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis**. Brasília - DF: 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/atencao-basica/cadernos-de-atencao-basica-18.pdf/view>. Acesso em: 05/03/2025;

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Prevenção da Transmissão Vertical do HIV, Sífilis e Hepatites Virais** [recurso eletrônico]. Brasília - DF: 2022. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_clinico_hiv_sifilis_hepatites.pdf. Acesso em: 05/03/2025.

Apêndice Único. Sugestões de Boas Práticas para a Garantia do Intervalo Adequado entre as Doses de Benzilpenicilina Benzatina no Tratamento da Sífilis em Gestantes

- Evidenciar no receituário de benzilpenicilina que se trata de gestação. Por exemplo: **GESTANTE/PRIORIDADE**. A informação pode ser registrada com um carimbo ou escrito à mão, de forma que chame a atenção para a necessidade de **priorização** da administração de penicilina para essa população;
- Agendar e registrar no receituário todas as datas das doses subsequentes das aplicações e informar **enfaticamente** que postergar o recebimento das injeções, pode comprometer o tratamento da Sífilis e, consequentemente, a saúde do conceito;
- Atentar ao planejamento das datas das aplicações da benzilpenicilina na Gestante, evitando que os períodos entre sete a nove dias após as aplicações coincidam com finais de semana e/ou feriados, interferindo diretamente no sucesso do tratamento. **Informar sobre a possibilidade de aplicação nas UPAs/PAs, que realizam procedimentos externos - aplicação de medicação injetável - nos períodos de menor fluxo - todos os dias no período das 6h às 9h e das 20h às 23h** (Disponível no Processo SEI nº 24.0.132074-6 - Como realizar Atendimento na recepção em casos de usuários que necessitam aplicar medicação externa na Rede de Urgência e Emergência);
- Registrar no próprio receituário a data e a Unidade de Saúde em que a aplicação foi realizada, pois este é um documento comprobatório do tratamento, assim a Gestante poderá apresentá-lo sempre que for solicitado;
- **Orientar as usuárias quanto a conservação da receita com os devidos registros de aplicação, pois poderá ser necessária a comprovação do tratamento em investigações/momento do parto/gestações futuras;**
- Atentar às questões empregatícias envolvidas na ida da Gestante a Unidade de Saúde para aplicação da penicilina, possivelmente ausentando-se do trabalho. Verificar junto à usuária a necessidade de declaração ou atestado que possam justificar essa ausência, diminuindo, assim, o risco de a Gestante não receber o tratamento devido;
- Confirmar e/ou atualizar o contato telefônico da Gestante, caso seja necessário a realização de busca ativa. Além de contato telefônico, podem ser utilizadas outras formas de contato, como aplicativos de mensagens, e-mail ou visita por agentes comunitários de saúde.
- Ressalta-se que os contatos realizados acerca do tratamento da Sífilis em Gestante devem zelar pelos princípios de sigilo sobre o agravo.

